BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH

Mã đề xuất CS-TMH-08; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

Mã ICD do bác sĩ xác nhận: nguồn ghi H65.3 nhưng mô tả chảy mủ/thủng nhĩ, cần phân biệt viêm tai giữa thanh dịch mạn với viêm tai giữa mủ mạn, không áp một mã cho mọi thể.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Khai thác tiền sử: Có chảy mũi, nghẹt mũi, có chảy dịch tai không?, có giảm nghe, có ù tai không?

- Thăm khám: Chảy dịch tai, Có lổ thủng màng nhĩ

Khám tai và đánh giá thính lực theo chỉ định; bác sĩ lựa chọn hình ảnh khi cần, không chụp Schüller thường quy cho mọi trường hợp.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1. Người bệnh nghe kém do thủng nhĩ

2.2. Người bệnh chảy dịch tai

2.3.Nguy cơ xảy ra biến chứng

2.4. Thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Giúp người bệnh nghe được

- Hướng dẫn người bệnh uống thuốc, tái khám, nhỏ tai, vệ sinh tai không tự ý nhỏ thuốc nam

3.2.Giảm dịch tai cho người bệnh

Giữ tai khô, làm sạch theo kỹ thuật được giao và thuốc theo y lệnh. Khi thủng nhĩ, xác nhận thuốc dùng an toàn với tai giữa; không tự bơm rửa hoặc nhỏ thuốc không rõ thành phần. Vá nhĩ do bác sĩ cân nhắc, không mặc định sau khô tai.

3.3.Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng:

Theo dõi đau/sốt, sưng sau tai, chóng mặt, liệt mặt và đau đầu; báo bác sĩ khi bất thường. Phẫu thuật và lịch khám do bác sĩ xác định.

3.4. Cung cấp kiến thức cho người bệnh:

Hướng dẫn thuốc, giữ tai khô, tránh ngoáy tai, tái khám và hỗ trợ giao tiếp/nghe kém; không tự cam kết phẫu thuật tránh mọi tái nhiễm.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Thực hiện các can thiệp theo kế hoạch trên, ghi thời điểm và đáp ứng; thuốc theo y lệnh, kỹ thuật theo quy trình riêng và phạm vi được phép.

5. Đánh giá

- Bệnh khỏe hơn , không xảy ra biến chứng, hết ù tai, không chảy dịch tai

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……